

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 22	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Dekubitusprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (2017)	

Durchführende:

- Pflegefachkraft (PFK)/ Pflegehilfskraft (PHK)

Pflegeziel:

- Jeder dekubitusgefährdete Patient erhält eine Prophylaxe, die die Entstehung eines Dekubitus verhindert.

Definition Mobilität: bezieht sich auf die Eigenbewegung des Menschen mit dem Ziel, sich fortzubewegen oder eine Lageveränderung des Körpers vorzunehmen und schließt die Fähigkeit zur Kontrolle einer Körperposition ein.

Ursachen für eine Dekubitusgefährdung (Screening)

- Druck- und Scherkräfte
- kann Position nicht selbst wechseln
- vorliegender Dekubitus
- abgeheilte Dekubitus Auffälligkeiten bei der Hautbeobachtung

Ursachen für eine Dekubitusgefährdung (differenzierte Risikoeinschätzung)

beeinträchtigte Fähigkeit, selbständig kleine Positionsveränderungen im Liegen oder Sitzen vorzunehmen, kaum oder keine Kontrolle über (druckentlastende) Körperpositionen im Liegen oder Sitzen, beeinträchtigte Fähigkeit zum selbständigen Transfer, es liegen körperliche, kognitive und psychische Beeinträchtigungen vor, Faktoren der sozialen und materiellen Umgebung spielen eine Rolle therapeutische Einflussfaktoren liegen vor (bspw. eine Mobilität beeinflussende Medikation), auf die Körperfläche eindrückende Katheter, Sonden, im Bett/auf dem Stuhl befindliche Gegenstände bzw. Hilfsmittel, nasale und endotracheale Tuben, unzureichend druckverteilende Hilfsmittel, zu fest oder schlecht sitzende Schienen oder Verbände, Bein- und Armprothesen, bekannte Durchblutungsstörungen, die einen Dekubitus befördern (Störung der Gewebetoleranz), einen Dekubitus befördernde Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes, beeinträchtigter Hautzustand, verminderte sensorische Wahrnehmung, Diagnostizierter Diabetes mellitus, Diabetisches Fußsyndrom, beeinträchtigter Ernährungszustand, erhöhte Hautfeuchtigkeit Allgemeiner Gesundheitszustand/Begleiterkrankungen, Schmerzen einhergehend mit Schonhaltungen/haltungsbedingte Risiken, vom Bewohner geäußerte Druckwahrnehmungen

Indikation:

- bei Bewegungseinschränkungen bzw.
- bei Schmerzen bzw.
- bei körperlicher Behinderung bzw.
- bei Sensibilitätsstörungen bzw.
- bei einem schlechten Ernährungs- und Allgemeinzustand bzw.
- bei veränderter Hautbeschaffenheit bzw.
- bei lokaler Druckeinwirkungen bzw.

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patienten informieren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 22	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Dekubitusprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (2017)	

- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Lagerungs- und Bewegungsnachweise, Nachweise für Fingertest etc.
- Lagerungsmaterialien, Körperpflegemittel
- für die Pflegekraft Einmalhandschuhe

Durchführung:

- die erste pflegfachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der Situationseinschätzung in den Themenfeldern und der vorgenannten Ursachen für eine Dekubitusgefährdung (Screening) durch die PFK unter der Rubrik relevantes Risiko und Phänomen in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).
- Wird die Kategorie von der PFK mit „nein“ angekreuzt liegt aus pflegfachlicher Sicht kein Dekubitusrisiko vor, es werden keine prophylaktischen Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- Wird die Kategorie „ja“ angekreuzt, muss die PFK zusätzlich eine Entscheidung zu der Kategorie „vertiefende Einschätzung notwendig“ (ja-nein) treffen, um festzulegen, ob hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für eine differenzierte Risikoeinschätzung besteht. Für die differenzierte Risikoeinschätzung sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen und ggf. die Maßnahmenplanung anzupassen
- tritt Dekubitusrisiko/ein Dekubitus als Phänomen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtsblatt und die Anpassung des Maßnahmenplanes
- ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtsblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtsblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen,
- Bei festgestellte Risiken/Ursachen anhand der pflegfachlichen Einschätzung sind Maßnahmen zu planen

Maßnahmen der Dekubitusprophylaxe sind:

- das Anlegen des Bewegungsförderungsplanes bei Einschränkungen in der Aktivität und Mobilität als Teil der Maßnahmenplanung
- Bewegung/Lagerung des Patienten in einem individuellen Zeitabstand der unter Zuhilfenahme des Fingertests und der Hautbeobachtung bestimmt wird und bei Veränderung zu evaluieren ist
- Durchführen von Bewegungen und Lagerungen gemäß Festlegungen des Maßnahmenplanes, Scherkräfte sind unbedingt zu vermeiden
- der Nachweis der umgesetzten Maßnahmen erfolgt auf dem Formblatt „Bewegungsförderungsplan(Nachweis)“
- bei Hautrötung Durchführung des Fingertestes, bleibt die Haut auch bei Druckausübung rot (nicht vorher weiß und dann rot), ist von einem Dekubitus Kategorie 1 auszugehen, der Arzt ist zu informieren, wenn der Fingertest trotz sofortiger prophylaktischer Maßnahmen auch nach 3 Tagen positiv bleibt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 22	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Dekubitusprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (2017)	

- Im Rahmen der allgemeinen Betreuung und der Wundversorgung bei einem Dekubitus, einem Ulcus cruris bzw. einem Diabetischen Fußulcus ist nach unserem Standard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ zu verfahren
- Mobilitätsförderung erfolgt bei jeder Aktivität im Rahmen der Grundpflege und weiterer betreuender oder pflegerischer Leistungen
- Nutzung von druckverteilenden Lagerungssystemen (entsprechend den Herstellerangaben), hierbei sind folgende Fragen im Vorhinein zu berücksichtigen: Anpassung an Körpergröße, Anpassung an Körpergewicht, Sicherung des Verdunstens von Flüssigkeiten, Minimierung von Reibungs- und Scherkräften, die Möglichkeiten der Eigenbewegungen, Vermeiden des Durchliegens bis auf den Grund, Berücksichtigung von Pneumoniegefährdung, den vorrangigen Pflege- und Therapiezielen; gefährdete Körperstellen, Vorlieben/Wünsche des Patienten, Kosten-Nutzen-Abwägung
- Lagerungssysteme ersetzen keine Lagerung und Eigenbewegung, sie müssen funktionsfähig sein
- Weich bzw. Superweichlagerung, wenn trotz sorgfältiger Lagerung Hautrötungen beobachtet werden, Freilagerung der Fersen mittels Kissen
- Körper- und Hautpflege, und -beobachtung
- Als Dekubitusprophylaxe werden aus pflegfachlicher Sicht nicht empfohlen: 90-Grad-Lagerung, die Verwendung von Lagerungsringen, synthetische Felle jeder Art, Wassermatratzen, Watteverbände oder Hydrokolloid-Verbände
- Patienten und Angehörige sind anzuleiten und zu beraten: zur Förderung der Eigenbewegung, zur Durchführung der Hautbeobachtung, zu druckentlastenden Hilfsmitteln sowie im Umgang mit druckverteilenden Hilfsmitteln. Relevante Inhalte sind im Pflegebericht zu vermerken, ggfls. ist ein Termin für ein erneutes Beratungsgespräch in der Maßnahmenplanung festzulegen
- Andere an der Pflege beteiligte Personengruppen wie: das Personal von Arztpraxen, OP-, Dialyse- und Röntgenabteilungen oder Transportdienste sind zur Sicherung der Kontinuität der Versorgung über die Dekubitusgefährdung zu informieren.
- Situationen in denen erforderliche Maßnahmen laut Risiko nicht umgesetzt werden können (kontraindiziert, aus gesundheitlichen Gründen nicht umsetzbar, andere Pflegeziele bspw. in der Terminalphase haben eine höhere Priorität bzw. Maßnahmen werden nicht anerkannt) sind im Pflegebericht zu dokumentieren
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten erfolgt zur fachlichen Reflexion eine Information an die PDL

Zusatz: bei vereinbarten Leistungen zur Mobilität ist auf folgendes zu achten:

- die Mobilität umfasst gemäß § 14 Abs. 4 SGB XI: das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung.
- hierzu ist der dementsprechende Leistungskomplex, sind Stunden bzw. Einzelleistungen vereinbart worden, der die Vorrichtungen zur Mobilität gemäß § 14 SGB XI beinhaltet, diese Leistungen sind fach- und sachgerecht durchzuführen und im Durchführungsnachweis zu dokumentieren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR ALTE UND KRANKE PATIENTEN
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 22	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Dekubitusprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (2017)	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA